

02 - 02- L'Hystérie - Pr. Adali

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce cours sur l'hystérie. Avant de l'entamer, je vous demande de prendre un petit moment pour noter ce que représente le terme hystérie pour vous. On va vérifier ses significations tout au long du cours.

Les objectifs de ce cours sont Définir l'hystérie Citer les équivalents de l'hystérie dans le DSM 5 Citer les données épidémiologiques de l'hystérie Décrire la clinique de l'hystérie Citer les particularités des symptômes hystériques et leurs significations Décrire la personnalité hystérique Décrire les modalités évolutives de l'hystérie Citer les facteurs étiopathogéniques de l'hystérie Faire le diagnostic différentiel Et enfin, décrire les principes thérapeutiques L'hystérie est une pathologie complexe, source de souffrance et d'invalidité. Elle est considérée comme étant une maladie de l'imagination en pratique médicale quotidienne, puisque l'examen somatique est normal, ainsi que les examens paracliniques. D'où le diagnostic en excès de l'hystérie par les somaticiens par rapport à de pathologies organiques réelles.

En effet, le diagnostic de l'hystérie est un diagnostic de facilité. En outre, l'hystérie est source de stigmatisation, car les malades ne sont pas considérés comme étant de vrais malades par les somaticiens. La première description de l'hystérie fut en 1900 av.

J.-C. Hippocrate décrit ce qu'il appelait l'utérus baladeur. Quand la matrice est aux hypochondres et produit de la suffocation, le blanc des yeux se renverse, la femme devient froide, elle grince des dents, la salive afflue dans la bouche et elle ressemble aux épileptiques. Au XIXe siècle, Charcot décrivait soigneusement les crises motrices hystériques en quatre stades.

Au XXe siècle, Freud décrit la névrose hystérique comme étant une névrose structurée caractérisée par la survenue de divers troubles somatiques, transitoires ou durables, sans lésions anatomocliniques sous-jacentes. Depuis 1980, le concept de névrose hystérique a été abandonné par le DSM. Sa symptomatologie a été répartie en deux grandes catégories, les troubles somatoformes et les troubles dissociatifs.

Dans le DSM-V, il y a eu un changement de classification qu'on va voir dans le cours. La prévalence de l'hystérie varie entre 0,5 à 2 %, avec une prédominance féminine, 2 à 5 femmes pour un homme. Les premiers symptômes apparaissent à l'adolescence ou à l'âge adulte jeune.

C'est un motif fréquent de consultation. 5 % des consultations à l'hôpital général et jusqu'à 30 % en neurologie. On note que 20 à 50 % des troubles neurologiques sont diagnostiqués en tant que troubles conversifs.

Trois grandes rubriques composent l'hystérie. Le trouble de conversion, appelé récemment trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle dans le DSM-V, les troubles dissociatifs et la personnalité histrionique. Cette répartition permet de concilier les descriptions traditionnelles et celles du DSM-V.

D'abord, on va traiter le chapitre des troubles de conversion. Le trouble de conversion ou trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle est composé de symptômes d'altération de la motricité volontaire ou des fonctions sensitives. Les types de symptômes retrouvés sont d'abord les symptômes moteurs comme paralysie, parésie, crise psychogène en épileptique, mouvements anormaux et autres.

Ensuite, les troubles sensitifs sensoriels comme l'hypoesthésie ou anesthésie, hyperesthésie, algie, intolérance aux stimuli comme la lumière et le bruit, l'atteinte auditive, fonatoire, visuelle sont assez rares. Troisièmement, les troubles neurovégétatifs comme les nausées, vomissements, coliques, dysurie, vaginisme, précordialgie, palpitations, épisodes d'inconscience et autres. Dans cette diapositive, vous retrouvez les critères DSM-V du trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle.

Il existe des manifestations aiguës et chroniques du trouble de conversion. Les manifestations aiguës sont sous forme de crise d'agitation psychomotrice avec décharge émotionnelle théâtrale, c'est ce qu'on appelle la grande crise de Charcot, des crises tétaniformes, crise syncopale ou l'hypotémie, crise d'allure convulsive et des crises pseudo-combateuses. Quant aux manifestations chroniques, elles sont durables, partielles ou totales.

Comment faire la différence entre une douleur d'origine convertive et une douleur d'origine organique ? D'abord, les douleurs d'origine convertive sont fréquentes, elles représentent 70% des symptômes convertifs, elles ont une expression théâtrale, elles sont continues, ne perturbant pas le sommeil paradoxalement, causant une impotence fonctionnelle importante. Enfin, elles sont résistantes à tout traitement symptomatique. Le deuxième grand chapitre est les troubles dissociatifs.

La dissociation est définie comme étant une altération soudaine et transitoire des fonctions normales d'intégration de la conscience, de l'identité et du comportement moteur. Dans le DSM 5, on décrit la dépersonnalisation des réalisations. La dépersonnalisation est une expérience d'irréalité, de détachement, d'être un observateur extérieur de ses propres pensées, sentiments, sensations, de son corps et de ses actes.

Quant à la déréalisation, c'est une expérience d'irréalité ou de détachement du monde extérieur. En effet, les personnes et objets sont ressentis comme étant irréels, perçus comme dans un rêve, sans vie ou visuellement déformés. Le deuxième chapitre des troubles dissociatifs est l'amnésie dissociative.

C'est l'incapacité à se rappeler des informations autobiographiques importantes. Elle peut être localisée concernant des événements localisés dans le temps. Il s'agit de la forme la plus fréquente, par exemple les mois ou les années entourant un abus dans l'enfance.

Elle peut être sélective concernant une partie de l'événement, le plus souvent traumatique.

L'amnésie généralisée est rare, c'est une perte complète de la mémoire. Le début est brutal et elle est fréquente en cas de stress extrême, notamment chez les anciens combattants et lors des agressions sexuelles.

La fugue dissociative correspond à un voyage errance associé à une amnésie de son identité ou d'autres informations autobiographiques importantes. Le troisième grand chapitre des troubles dissociatifs est les troubles dissociatifs de l'identité appelée personnalité multiple. C'est la présence d'au moins deux états de personnalité, chacune prédominant à un moment déterminé, ou une expérience de possession avec amnésie dissociative.

Dans la personnalité hystérique, il y a histrionisme ou théâtralisme, avec une volonté de plaire, de séduire, d'accaparer l'attention, suggestibilité, modification de rôle en fonction des circonstances et avec une tendance à la dramatisation. L'hypéractivité émotionnelle comporte une hypéréxpressivité affective, des troubles caractériels avec intolérance à la frustration, irritabilité et une labilité de l'humeur. La dépendance affective se manifeste soit par la recherche active de valorisation dans une tâche altruiste, soit par une passivité avec immaturité voire infantilisme, en quête de réassurance et de protection.

On note chez les patientes hystériques une crainte de la sexualité avec évitement des relations sexuelles, malgré une hypersexualité apparente avec séduction. Pour poser le diagnostic positif, l'anamnèse devra rechercher les antécédents personnels de conversion hystérique ou de consultation médicale fréquente pour des troubles fonctionnels. Les troubles sexuels à type de frigidité, impuissance, évitement de la sexualité et autres.

La date de début des troubles qui est des premiers symptômes qui est généralement avant l'âge de 30 ans. Les symptômes actuels surviennent généralement suite à un stress, un traumatisme psychologique ou physique. C'est ce qu'on appelle un facteur déclenchant.

Les symptômes actuels peuvent survenir aussi lors des périodes d'adolescence, du milieu de vie, lors des périodes de licenciement, retraite ou autres. Ils sont présentés de manière dramatisée par le patient dans une belle indifférence, avec altération du fonctionnement social et professionnel. Les examens somatiques et les examens paracliniques sont normaux.

On note la fréquence des comorbidités psychiatriques, notamment la dépression, troubles de la personnalité et autres. Il existe plusieurs formes cliniques de l'hystérie. Les formes monosymptomatiques avec atteinte d'une seule fonction physique ou psychique, particulièrement les algies lombaires ou gynécologiques chez la femme.

Les formes polysymptomatiques comportent des plaintes somatiques multiples, une personnalité stréonique avec retentissement extrême, notamment une polyconsommation de médicaments et de soins, un handicap chronique affectif, familial et professionnel et des complications psychiatriques par la dépression ou les tentatives de suicide. L'hystérie peut aussi concerner l'homme. Il s'agit d'une forme monosymptomatique avec difficultés professionnelles importantes.

Il existe une forme collective de l'hystérie qui renvoie à l'aspect culturel de cette pathologie. Quelles sont les particularités des symptômes hystériques et leurs significations? Il y a toujours un bénéfice du symptôme. D'abord, les bénéfices primaires en tant que mécanisme de défense névrotique permettant le refoulement d'une représentation mentale trop douloureuse ou trop angoissante pour le moi.

Les bénéfices secondaires qui sont des avantages inconsciemment attendus tels qu'un réaménagement familial, un réaménagement du travail, l'évitement de responsabilités, de conflits et autres. La belle indifférence est l'absence d'intérêt concernant la nature ou les conséquences du symptôme hystérique. Le choix du symptôme hystérique ne se fait pas au hasard.

Il est fonction des souvenirs ou représentations imaginaires qui lui sont associées et de son aptitude à symboliser le conflit inconscient. Le but du symptôme est de séduire, attirer l'attention, manipuler, agresser ou faire souffrir. Il touche les fonctions de la vie de relation.

C'est une paralysie de fonction et non pas d'organe. Les symptômes hystériques sont atypiques. Ils ne respectent ni la systématisation anatomophysiologique et il n'existe pas de lésions anatomiques ni de perturbations biologiques sous-jacentes.

L'évolution de l'hystérie est marquée par la sensibilité à la suggestion, l'aggravation par les émotions, l'extension des troubles et la marginalisation et invalidité sociale. L'hystérie peut se compliquer de décompensations anxio-dépressives, de tentatives de suicide, de conduite addictive et de surconsommation d'actes médicaux et de médicaments. Le pronostic dépend de l'entourage et de la prise en charge.

Plusieurs théories ont été émises pour expliquer l'hystérie. D'abord la théorie psychanalytique où un événement traumatique déclencheur récent peut réactiver un traumatisme de l'enfance, notamment un abus. Les conflits psychiques inconscients s'expriment dans le corps, donnant des conversions, ou dans le psychisme lui-même, donnant la dissociation.

Quant à la personnalité histrionique, elle serait due à un arrêt de développement au stade génital oedipien, d'où la séduction hypersexualisée et l'érotisation du corps. Selon la théorie comportementale et cognitive, il existe chez les patients hystériques des troubles de l'attention. Cette attention est focalisée davantage sur les sensations corporelles mal interprétées, plutôt que sur la perception des stimuli extérieurs.

Il n'existe pas de modèle neurobiologique clairement établi expliquant l'hystérie. Les diagnostics différentiels de l'hystérie se font avec d'abord les affections organiques. Ces affections doivent toujours être éliminées en premier.

La suspicion de la nature hystérique de la crise ne dispense pas d'un examen physique complet qui devrait rassurer médecins et malades. Ces affections organiques peuvent être l'épilepsie, les

tumeurs cérébrales, les AVC, les maladies de système tel le lupus et autres. Le deuxième diagnostic différentiel se fait avec les maladies psychosomatiques.

Dans ce cas de figure, il existe un substratum anatomophysiologique sous-jacent. La simulation est aussi un diagnostic différentiel de l'hystérie. Elle se voit surtout dans les milieux carcéraux et militaires.

On retrouve des bénéfices de la maladie simulée. Dans l'hypochondrie, les plaintes expriment une peur des maladies, contrairement à la belle indifférence chez les patientes hystériques. Le diagnostic différentiel se fait aussi avec certaines pathologies psychiatriques, notamment la dépression et les troubles anxieux.

La première recommandation dont la prise en charge est que le somatique prime. On s'assurera d'éliminer un problème somatique sous-jacent d'abord. Lors de l'annonce du diagnostic d'hystérie, il faut reconnaître la réalité de la plainte, rassurer sur l'absence d'affections organiques graves.

Il ne faut ni rejet, ni mépris. Il ne faut pas faire de prescriptions abusives de médicaments. Le médecin doit adopter une attitude neutre et bienveillante et son discours doit valoriser la guérison.

L'hospitalisation au milieu psychiatrique peut être indiquée pour séparer le patient ou la patiente d'un environnement conflictuel dramatisant qui va aggraver la symptomatologie ou pour traiter les complications psychologiques, notamment la dépression, les tentatives de suicide et autres. L'hospitalisation doit être de courte durée pour éviter de chroniciser le trouble et pour contrôler les bénéfices secondaires. Aucun traitement médical n'a prouvé son efficacité dans le cas de l'hystérie.

Les anxiolytiques peuvent être prescrits de courte durée car il y a un risque important de dépendance. On peut prescrire les antidépresseurs s'il y a une dépression associée. On note chez les patientes hystériques un effet placebo très marqué car elles sont très suggestibles.

La psychothérapie de soutien a pour objectif de favoriser la verbalisation par la patiente, encourager une hygiène de vie, soutenir moralement le patient sans prendre partie d'eux dans ses conflits. La psychothérapie d'inspiration psychanalytique est l'indication de choix dans le traitement de l'hystérie. Elle vise à comprendre soi-même et se dégager d'une problématique inconsciente.

La prise en charge sociale a pour objectif de canaliser les besoins affectifs des patientes dans une activité sociale ou professionnelle valorisante et compensatrice. Les thérapies physiques comme la relaxation peuvent être prescrits chez les patientes hystériques aussi. Comment gérer une crise convertie aiguë ? D'abord, il faut bannir certaines pratiques comme les gifles, faire sentir les terres à la patiente et autres.

Il faut isoler et éloigner les spectateurs voire hospitaliser la patiente, dédramatiser, rassurer, encourager la verbalisation et utiliser l'écoute bienveillante. A noter que les manifestations aiguës réagissent mieux au traitement que les manifestations chroniques anciennes. En conclusion, l'hystérie est la pathologie mentale qui sollicite le plus le savoir et le pouvoir médical.

Les patients hystériques sont souvent victimes d'attitudes négatives de la part des praticiens. Ces derniers doivent comprendre l'importance de l'aspect relationnel dans cette maladie. Je vous remercie pour votre attention.